

NS

IDADE: 77	PESO: 69	ALTURA: 1,65	PROFISSÃO: Retirado / do Lar
SINTOMAS: Laringite Refluxo; Presença CIA desde Nascimento - vai interm. ↓ Memória;			
QUEIXAS: Ronco; Insônia mantendo; Episódios "sensação de sufocamento"			
MEDICAMENTOS: Sintetóide tireóide; Naprox; Rosacar; Vitaminas;			
MÉDICO:			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates 2x; caminhada			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME:		HORA QUE ACORDA:	
COCHILHO (X) S () N 20'		DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE	
TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N		PET NO QUARTO: () S () N	
BEBIDA ALCOÓLICA: () S (X) X NA SEMANA () N 3x semana - vinho.			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO/NOITE:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH: 45,5 e 46	SPO2: 86%.
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Laringite por refluxo; Disfonia crônica e lary. Rinite sazonal			
CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA Ade noide após câncer			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: -			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA ECO FE: 67%.			
() ORTOPÉDICA		(S) NEUROLÓGICA () OUTROS:	
POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S () N		SPO2 CI/CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
31/07/2025 Avaliação. Auto 42-40 cmH2O		Eficiência cons. 44%.	
+ tentou usar por Resmed másc P30;		↓ N3 0,7%.	
para acompanhamento Remote - e pet vai morar em SP		↑ N2 70%.	
		↓ REM 0%.	
		7 hi pop	
		pressão	
		10-30	

van Wagner

Peso: 131 kg

INSTITUTO DO
SONO

Instituto do Sono
Rua Marselhesa, 500 - Vila Clementino
São Paulo - SP - CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: **BERNADETE EDWARDS ALLODI**
Sexo: **Feminino** Idade: **76 anos**
Exame: **34766151** Data: **10/06/2025**
Médico Solic.: **LEANDRO FRANCHI**

Atendimento: **18440287**
ID: **3508986**

Conclusão

A polissonografia basal mostrou:

- Aumento acentuado do índice de apneia/hipopneia devido a eventos obstructivos (IAH: 45,5 eventos/h);
- Presença de ronco durante o exame;
- Períodos de dessaturação da oxi-hemoglobina durante o sono;
- Diminuição do sono de ondas lentas e ausência de sono REM;
- Eficiência do sono diminuída devido ao aumento do tempo em vigília após o adormecer.

Mariana Delgado

MARIANA DELGADO FERNANDES
CRM 179521

BERNADETE EDWARDS ALLODI: 3508986

Eventos respiratórios

	Total de eventos	Índices (por hora)				Duração (seg)	
		REM	NREM	TTS	Supino	Não supino	Máxima Média
Apneia obstrutiva (AO)	38		11.2	11.2	15.1	0.00	28.5 16.3
Apneia mista (AM)	9		2.7	2.7	3.6	0.00	23.0 17.8
Hipopneia obstrutiva (HO)	94		27.2	27.8	*	*	25.0 15.5
RERA	0		0	0.0	0.0	0.00	0.0 0.0
AO+AM+HO	141.00	0.00	74.20	41.70	*	*	76.50 49.60
AO+AM+HO+RERA	141.00	0.00	74.20	41.70	*	*	76.50 49.60
Apneia central (AC)	13		13	3.8	5.2	0.00	18.5 14.5
Hipopneia central (HC)	0		0.0	0.0	*	*	0.0 0.0
AC+HC	13.00	0.00	13.00	3.80	*	*	18.50 14.50

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 41.70 (por hora)

IAH(O+C): 45.5 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 3.80 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: 28.6 (por hora) em supino e 25.53 (por hora) em não supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 45.5 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.
- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

Saturação da oxí-hemoglobina (SpO₂)

Saturação média	93%	Saturação TTR < 90%	2.1% (9.7 min)
Saturação mínima	86%	Saturação REM < 90%	0.0% (0.0 min)
		Saturação NREM < 90%	1.7% (7.7 min)
Saturação média na vigília	94%		
Saturação média no sono REM	%	Saturação < 80%	0.0% TTR (0.0 min)
Saturação média no sono NREM	92%	Saturação < 70%	0.0% TTR (0.0min)
Total de dessaturações	146		
Índice de dessaturação no sono		43.2 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono REM		(por hora)	
Índice de dessaturação no sono NREM		39.3 (por hora)	